

ORIGINAL

Prevalencia e impacto del síndrome de *burnout* en trabajadores sanitarios de España y Latinoamérica



Lennin Jose Tolentino Hinojosa^{a,b,1}, Laura Pardo^{c,1},
Guillermo Suarez-Santamaría Silván^d, Alberto Rubio López^{d,e},
Amílcar Tinoco Solorzano^{a,b,f}, Rosario Espinoza Flores^{a,g},
Jose M. Gómez García^{c,h} y Pablo Cardinal-Fernández^{c,i,*}

^a Servicio de Cuidados Intensivos e Intermedios, Hospital Nacional Ramiro Priale Priale-Essalud, Huancayo, Perú

^b Facultad de Medicina Humana, Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Perú

^c Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitario HM Torrelodones, Madrid, España

^d Facultad de Medicina, Universidad CEU San Pablo, Madrid, España

^e Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitario HM Montepríncipe, Madrid, España

^f Facultad de Medicina Humana, Universidad de San Martín de Porres, Centro de Investigación de Medicina de Altura (CIMA), Lima, Perú

^g Facultad de Medicina Humana, Universidad Peruana los Andes, Huancayo, Perú

^h Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España

ⁱ Facultad de Medicina, Universidad Camilo José Cela, Madrid, España

Recibido el 17 de septiembre de 2024; aceptado el 14 de febrero de 2025

Disponible en Internet el 10 de marzo de 2025

PALABRAS CLAVE

Síndrome de burnout;
Prevalencia;
Impacto;
Trabajo sanitario;
España;
Latinoamérica

Resumen

Objetivo: El objetivo de este estudio fue estimar la prevalencia del síndrome de *burnout* (SB) en trabajadores sanitarios de España y Latinoamérica, así como evaluar su impacto en la percepción del trabajo de los mismos.

Diseño: Estudio observacional, internacional, multicéntrico realizado entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2023.

Participantes: Los participantes fueron trabajadores sanitarios mayores de 18 años que respondieron una encuesta online y que habían mantenido la misma posición laboral durante al menos dos años antes de completar el cuestionario. Además, debían residir en España o en un país de Latinoamérica y comprender el idioma español.

Mediciones principales: El SB se diagnosticó utilizando la escala *Maslach Burnout Inventory* (MBI). Además, se recogieron datos demográficos y laborales, y se evaluó la percepción del trabajo a través de preguntas dicotómicas relacionadas con el arrepentimiento de trabajar en el sector sanitario, el deseo de abandonar la profesión y la intención de cambiar de puesto.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: pablocardinal@hotmail.com (P. Cardinal-Fernández).

¹ Coautores.

Resultados: Se incluyó a 646 participantes, con una media de 43 años (rango intercuartil 35-51). De ellos, 367 (57%) fueron mujeres. Distribución profesional: 515 (80%) médicos, 58 (9%) enfermeros, 53 (8%) fisioterapeutas y 20 (3%) de «otras profesiones».

No se observaron diferencias significativas en la prevalencia de SB entre España (21%) y Latinoamérica (24%). El SB se diagnosticó en 153 (24%) participantes, quienes se diferenciaron por su menor edad y años de experiencia laboral. Tampoco se presentaron diferencias entre la posición del trabajador sanitario.

El SB mostró un impacto significativo en la percepción del trabajo, con una mayor proporción de participantes que se arrepintieron de trabajar en la sanidad, pensaron en abandonar la profesión o en cambiar su puesto de trabajo, especialmente en Latinoamérica.

Conclusiones: La prevalencia del SB es alta y no depende de la ubicación geográfica donde ejerce su profesión el trabajador sanitario. El impacto en la percepción del trabajo es considerable, lo que resalta la importancia de implementar estrategias para prevenir y mitigar este síndrome, mejorando así la calidad asistencial.

© 2025 Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Se reservan todos los derechos, incluidos los de minería de texto y datos, entrenamiento de IA y tecnologías similares.

KEYWORDS

Burnout syndrome;
Prevalence;
Impact;
Healthcare work;
Spain;
Latin America

Prevalence of burnout syndrome (BS) and its impact in the perception of their work in healthcare workers from Spain and Latin-America

Abstract

Objective: The aim of this study was to estimate the prevalence of burnout syndrome (BS) in healthcare workers from Spain and Latin America, as well as to assess its impact on their perception of work.

Design: Observational, international, multicenter study conducted between February 1st and April 30th, 2023.

Participants: Participants were healthcare workers over 18 years of age who completed an online survey and had maintained the same job position for at least two years prior to completing the questionnaire. Additionally, they had to reside in Spain or Latin America and understand the Spanish language.

Main measurements: BS was diagnosed using the Maslach Burnout Inventory (MBI). Demographic and work-related data were also collected, and the perception of work was analyzed through dichotomous questions related to regret about working in healthcare, the desire to leave the profession, and the intention to change job positions.

Results: A total of 646 participants were included, with a mean age of 43 years (IQR 35-51). Of the participants, 367 (57%) were women, and the professions included 515 (80%) doctors, 58 (9%) nurses, 53 (8%) physiotherapists, and 20 (3%) from other professions. No significant differences were observed in BS prevalence between Spain (21%) and Latin America (24%). BS was diagnosed in 153 (24%) participants, who were younger and had fewer years of work experience compared to the rest. No differences were found based on the healthcare worker's job position.

BS showed a significant impact on the perception of work, with a higher proportion of participants regretting working in healthcare, considering leaving the profession, or wanting to change job positions, particularly in Latin America.

Conclusions: The prevalence of BS is high and does not depend on the geographical location where the healthcare worker practices their profession. The impact on the perception of work is considerable, highlighting the importance of implementing strategies to prevent and mitigate this syndrome, thereby improving the quality of care.

© 2025 Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.

Introducción

El síndrome de *burnout* (SB), o «desgaste profesional», es una condición que afecta profundamente al personal

sanitario, caracterizada por agotamiento emocional, despersonalización y una disminución en la percepción de realización personal. Estos síntomas son particularmente preocupantes en un sector esencial para el bienestar social,

dado que afectan tanto la salud de los profesionales como la calidad de la atención brindada a los pacientes.

Diversos estudios han evidenciado una alta prevalencia del SB en profesionales de la salud, asociada a factores como largas jornadas laborales, presión emocional constante y recursos insuficientes¹⁻¹². Sin embargo, aun es limitado el conocimiento sobre cómo el SB afecta la percepción que estos trabajadores tienen sobre su rol profesional y su capacidad para desempeñarlo eficazmente. Este aspecto es crucial, ya que una percepción negativa puede exacerbar los efectos del síndrome, perpetuando un ciclo de insatisfacción laboral y disminución de la calidad del cuidado.

La reciente pandemia de COVID-19 ha agravado significativamente esta problemática. Durante la crisis sanitaria, los profesionales de la salud enfrentaron desafíos sin precedentes: sobrecarga laboral, temor al contagio, pérdida de colegas y pacientes, y una alta demanda emocional debido a la naturaleza crítica de los casos atendidos. Este contexto no solo incrementó la incidencia del *burnout*, sino que probablemente también intensificó su impacto, pudiendo hacer que el conocimiento previo a esta crisis haya quedado obsoleto o inexacto.

El presente estudio busca analizar la prevalencia del SB en diversos países de Iberoamérica durante una fase post-pandemia, así como explorar el impacto del mismo en la percepción que tienen los profesionales sanitarios sobre su trabajo. Conocer la prevalencia y el impacto del SB en el personal sanitario es fundamental para desarrollar estrategias de intervención específicas, dirigidas no solo a prevenir futuros brotes de desgaste profesional, sino también a fortalecer los sistemas de salud ante posibles crisis. Abordar esta problemática es prioritario para garantizar tanto el bienestar de los trabajadores sanitarios como la resiliencia del sistema de salud frente a retos similares en el futuro.

Material y métodos

Este estudio es observacional, internacional y multicéntrico, realizado mediante una encuesta online y anónima distribuida a través de redes sociales entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2023.

Criterio de inclusión

Trabajadores sanitarios, con edad igual o mayor de 18 años, que comprendan (escrito y lectura) el idioma castellano, que hayan permanecido en la misma posición laboral durante los dos años previos a la realización del cuestionario y que residieran en España o en algún país de Latinoamérica.

Definición del síndrome de *burnout*

El SB se diagnosticó mediante el formulario *Maslach Burnout Inventory* (MBI) (tabla suplementaria 1). El cuestionario es una herramienta validada¹³⁻¹⁹ que incluye 22 preguntas agrupadas en tres dimensiones: cansancio emocional, despersonalización y logro personal. Para ser diagnosticado con SB, el participante debe obtener una puntuación alta en las tres áreas.

Recogida de datos

Se registró el formulario MBI y las siguientes variables demográficas: edad, sexo, país de residencia, profesión y antigüedad laboral. Para evaluar el impacto del SB en la percepción del trabajo, se incluyeron tres preguntas con respuesta dicotómica: «¿Te arrepientes de trabajar en sanidad?», «¿Has pensado en abandonar la sanidad?» y «¿Has pensado cambiar la posición que tienes en la sanidad?» (tabla suplementaria 2).

Análisis estadístico

Las variables continuas se expresaron como mediana y rango intercuartil; las cualitativas, como frecuencias absolutas y porcentuales. La asociación entre variables cualitativas se evaluó mediante test de Fisher o chi-cuadrado de Pearson, según correspondiera; entre cualitativas y cuantitativas, mediante t de Student o U de Mann-Whitney, según correspondiera. La prueba de Mantel-Haenszel se utilizó para evaluar el efecto de los factores de confusión entre variables cualitativas. Se consideró un umbral de significación estadística de $p < 0,05$.

Resultados

Se incluyeron 646 participantes, con una edad de 43 (35; 51) años; 367 (57%) fueron mujeres. Distribución profesional: 515 (80%) médicos, 58 (9%) enfermeros, 53 (8%) fisioterapeutas y 20 (3%) de otras profesiones (tabla 1).

Las áreas hospitalarias en las que trabajaban los participantes fueron: cuidados intensivos, hospitalización, urgencias/emergencias y consultas.

No se observaron diferencias significativas entre los participantes de España y Latinoamérica en cuanto a la distribución por género (63 [61,2%] vs 304 [56%], $p < 0,33$); edad (45 [33; 58] vs 41 [36; 50], $p = 0,15$), ni en los años de experiencia laboral (13 [5; 21] vs 10 [5; 19], $p = 0,14$). Sin embargo, la distribución de las profesiones sí varió entre los participantes de España y Latinoamérica (tabla 1).

Los países latinoamericanos en los que trabajaban los participantes incluyeron Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Guatemala, México y Ecuador.

El SB se diagnosticó en 153 (24%) participantes, quienes se caracterizaron por ser más jóvenes y tener menos años de experiencia laboral (tabla 2). No se encontró asociación significativa entre el SB y la región geográfica de procedencia, ni con la profesión (tabla 2).

En relación con la percepción del trabajo, el SB se asoció con un aumento en la proporción de participantes que se arrepintieron de trabajar en la sanidad (58 [38%] vs 40 [8%], OR: 6,9 [4,4; 11,0], $p < 0,01$); que pensaron en abandonar la sanidad (102 [67%] vs 142 [29%], OR: 4,9; IC 95%: 3,35; 7,29, $p < 0,01$) y que consideraron cambiar la posición de su trabajo (117 [77%] vs 224 [45%], OR: 3,90; IC 95%: 2,58; 5,90, $p < 0,01$). Estos efectos están más pronunciados en los participantes residentes en países de Latinoamérica en comparación con los de España (tabla 3).

Tabla 1 Valores demográficos distribuidos por regiones

	Total (n = 646 100%)	España (n = 103)	Latinoamerica (n = 543)	p
<i>Edad (años)</i>	43 (35;51)	45 (33;58)	41 (36;50)	0,148
<i>Sexo (femenino)</i>	367 (57%)	63 (61,2%)	304 (56%)	0,331
<i>Número de años en el puesto de trabajo (años)</i>	10 (5;20)	13 (5;21)	10 (5;19)	0,148
<i>Grupo sanitario</i>				0,006
Médico	515 (80%)	95(92%)	420(77%)	
Enfermero	58 (9%)	4 (3,9%)	54 (9,9%)	
Fisioterapeuta	53 (8%)	2 (2%)	51 (9,4%)	
Miscelánea	20 (3%)	2 (2%)	18 (3%)	

Tabla 2 Valores demográficos de participantes con SB y sin SB

	Total (n = 646 100%)	SB (n = 153; 24%)	Sin SB (n = 493; 76%)	p
<i>Edad (años)</i>	43 (35;51)	39 (34;45)	43 (35;53)	0,000
<i>Sexo (femenino)</i>	367 (57%)	93 (61%)	274 (56%)	0,256
<i>Lugar de procedencia (España)</i>	103 (16%)	22 (14%)	81 (16%)	0,545
<i>Número de años en el puesto de trabajo (años)</i>	10 (5;20)	9 (5;14)	11 (5;20)	0,004
<i>Grupo sanitario</i>				0,424
Médico	515 (80%)	120 (78%)	385 (80%)	
Enfermero	58 (9%)	11 (7%)	47 (10%)	
Fisioterapeuta	53 (8%)	15 (10%)	38 (8%)	
Miscelánea	20 (3%)	7(5%)	13 (3%)	

Tabla 3 Impacto del SB en los trabajadores sanitarios

	Origen	SB		OR (IC 95%)	p
		Sí	No		
¿Te arrepientes de trabajar en la sanidad?	España	Sí	10 (46%)	5,3 (1,85; 15,19)	0,000
		No	12 (55%)		
	Latinoamérica	Sí	48 (37%)	7,63 (4,54; 12,82)	
		No	83 (63%)		
¿Has pensado en abandonar la sanidad?	España	Sí	13 (60%)	2,88 (1,09;7,600)	0,000
		No	9 (41%)		
	Latinoamérica	Sí	89 (68%)	5,47 (3,57; 8,37)	
		No	42 (32%)		
¿Has pensado cambiar la posición que tienes en la sanidad?	España	Sí	16 (73%)	3,01 (1,07; 8,49)	0,000
		No	6 (27%)		
	Latinoamérica	Sí	101 (77%)	4,09 (2,60, 6,42)	
		No	30 (23%)		

Discusión

El presente estudio encontró que el SB tiene una prevalencia del 24%, sin diferencias entre España y Latinoamérica. El efecto del SB en la percepción del trabajo es muy relevante, destacándose un incremento en el sentimiento de «arrepentimiento» por trabajar en sanidad, del deseo de abandonar la mencionada área y/o de cambiar de profesión. Efectos que se incrementan en los profesionales que ejercen en Latinoamérica.

En referencia a la prevalencia del SB, Salamero y Baranda Areta²⁰, en una muestra de 847 personas de España durante 2015, reportaron una prevalencia del 34%; Panagioti et al.²¹, en un metaanálisis que incluyó 42.473 personas proceden-

tes de Europa y Estados Unidos durante los años 2006 a 2017, reportaron una prevalencia del 67%; Ovejas et al.²², en una muestra de 214 personas de España durante 2020, encontraron una prevalencia del 40%. Algunos autores han resaltado el impacto de la reciente pandemia de COVID-19 en la prevalencia del SB. Por ejemplo, Alkhamees et al.²³, en un metaanálisis que incluyó 6.299 médicos de distintos países de Europa y América, reportaron una prevalencia del 41%. Nuestro estudio encontró una prevalencia inferior a la reportada en los estudios precedentes. Esta aparente incongruencia podría explicarse por la utilización de diferentes escalas diagnósticas. En nuestro caso, usamos la MBI, que es de aceptación internacional^{13,14-19,24}, lo cual incrementa la validez externa del estudio. Una segunda explicación podría

ser que la pandemia generó una migración de profesionales sanitarios a otras actividades no relacionadas con el cuidado de pacientes, determinando que el subgrupo que persiste trabajando en la sanidad sea más resistente a este síndrome. Por último, no se puede descartar que esta reducción en la prevalencia simplemente refleje el azar.

Otro aspecto inesperado es el hecho de no encontrarse diferencias en la prevalencia entre España y Latinoamérica, resultado que debe ser considerado con cautela, dado que el subgrupo de Latinoamérica incluyó a múltiples países con realidades socioeconómicas y asistenciales distintas.

En referencia a las variables demográficas, el perfil del paciente con SB es el de una mujer de mediana edad con una década de trabajo, lo cual corresponde con el perfil reportado en otras series^{4,25,26}.

Varios autores recientemente han postulado la irrupción de sustanciales cambios sociales, los cuales podrían impactar en la percepción del trabajo^{20-22,26-30}. Nuestro estudio halló una asociación entre el SB y un mayor deseo de abandonar el trabajo, arrepentimiento profesional y búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Estos tres factores podrían afectar negativamente la atención al paciente. Si bien, a nuestro entender, es la primera vez que se realizan estas tres preguntas entre España y Latinoamérica, el impacto adverso del SB en el trabajo sanitario ha sido demostrado repetidamente. Así, Gálvez et al.³⁰ reportaron que el trabajador sanitario se siente agotado, decepcionado, desvinculado y desinteresado de la actividad laboral.

Este estudio presenta algunas limitaciones. En primer lugar, al ser una encuesta en línea, se desconoce la proporción y las características de la población general que tuvo acceso o eligió participar, lo que introduce un posible sesgo de selección, frecuente en este tipo de investigaciones. Además, el hecho de que la participación sea voluntaria podría implicar que los trabajadores más afectados por el SB o aquellos más interesados en el tema sean los que se inclinan a responder, lo que genera un sesgo de autoselección. Este factor puede llevar a una sobreestimación de la prevalencia y los efectos del síndrome en la muestra estudiada^{20,22,25,26,28,31}. En segundo lugar, los datos demográficos y otros factores que podrían influir en el SB fueron limitados y no permiten inferir asociaciones causales. Por otro lado, también tiene fortalezas. La primera y más evidente es el tamaño muestral. Segundo, la utilización de una escala diagnóstica para el SB reconocida y validada a nivel internacional. Tercero, el período de tiempo en el cual se realizó fue breve, lo cual permite reducir el impacto que podrían tener factores externos en el SB.

En suma, el SB es una entidad frecuente en el sistema sanitario y afecta a 1 de cada 4 personas, proporción que es similar en España y en Latinoamérica. El SB influye negativamente en la percepción que el trabajador sanitario tiene respecto a su profesión. Identificar el subgrupo de personas con SB permitiría elaborar estrategias preventivas y de reducción del impacto, lo cual podría conllevar a la mejora en la calidad asistencial.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Anexo. Material adicional

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en [doi:10.1016/j.actci.2025.02.004](https://doi.org/10.1016/j.actci.2025.02.004).

Bibliografía

1. Martos Martínez A, Pérez Fuentes MC, Molero Jurado MM, Gázquez Linares JJ, Simón Márquez MM, Barragán Martín AB. Burnout y engagement en estudiantes de Ciencias de la Salud. *Eur J Invest Health Psychol Educ*. 2018;8:23–36 [consultado 13 Sep 2023]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6477852&info=resumen&idioma=ENG>
2. Kang L, Li Y, Hu S, Chen M, Yang C, Yang BX, et al. The mental health of medical workers in Wuhan, China dealing with the 2019 novel coronavirus. *Lancet Psychiatry*. 2020;7:e14 [consultado 13 Sep 2023]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32035030/>
3. Rodrigues H, Cobucci R, Oliveira A, Cabral JV, Medeiros L, Gurgel K, et al. Burnout syndrome among medical residents: A systematic review and meta-analysis. *PLoS One*. 2018;13:e0206840 [consultado 13 Sep 2023]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30418984/>
4. Galanis P, Vraka I, Fragkou D, Bilali A, Kaitelidou D. Nurses' burnout and associated risk factors during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. *J Adv Nurs*. 2021;77:3286–302 [consultado 13 Sep 2023]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33764561/>
5. Schaufeli WB, Martínez IM, Pinto AM, Salanova M, Barker AB. Burnout and engagement in university students. *J Cross-Cult Psychol*. 2002;33:464–81. <http://dx.doi.org/10.1177/0022022102033005003>, <https://doi.org/10.1177/0022022102033005003>
6. Prins JT, Gazendam-Donofrio SM, Tubben BJ, van der Heijden FMMA, van de Wiel HBM, Hoekstra-Weebers JEHM. Burnout in medical residents: A review. *Med Educ*. 2007;41:788–800 [consultado 13 Sep 2023]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17661887/>
7. Shanafelt TD, Bradley KA, Wipf JE, Back AL. Burnout and self-reported patient care in an internal medicine residency program. *Ann Intern Med*. 2002;136:358–67 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11874308/>.
8. Nantsupawat A, Nantsupawat R, Kunaviktikul W, Turale S, Poghosyan L. Nurse burnout, nurse-reported quality of care, and patient outcomes in Thai hospitals. *J Nurs Scholarsh*. 2016;48:83–90 [consultado 13 Sep 2023]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26650339/>
9. Poghosyan L, Clarke SP, Finlayson M, Aiken LH. Nurse burnout and quality of care: Cross-national investigation in six countries. *Res Nurs Health*. 2010;33:288–98 [consultado 13 Sep 2023]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20645421/>
10. Boamah SA, Read EA, Spence Laschinger HK. Factors influencing new graduate nurse burnout development, job satisfaction and patient care quality: A time-lagged study. *J Adv Nurs*. 2017;73:1182–95 [consultado 13 Sep 2023]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27878844/>
11. Dall'Ora C, Ball J, Reinius M, Griffiths P. Burnout in nursing: A theoretical review. *Hum Resour Health*. 2020;18:41 [consultado 13 Sep 2023]. Disponible en: <https://human-resources-health.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12960-020-00469-9>
12. Moro JS, Soares JP, Massignan C, Oliveira LB, Ribeiro DM, Cardoso M, et al. Burnout syndrome among dentists: A systematic review and meta-analysis. *J Evid Based Dent Pract*. 2022;22:101724 [consultado 13 Sep 2023]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36162888/>

13. Maslach C, Jackson SE. The measurement of experienced burnout. *J Organ Behav*. 1981;2:99–113.
14. García García JM, Herrero Remuzgo S, León Fuentes JL. Validez factorial del *Maslach Burnout Inventory* (MBI) en una muestra de trabajadores del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla. *Apunt Psicol*. 2007;25:157–74 [consultado 13 Sep 2023]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2350787&info=resumen&idioma=SPA>
15. Peiró Silla JM, Gil Monte PR. Validez factorial del *Maslach Burnout Inventory* en una muestra multiocupacional. *Psicothema*. 1999;11:679–89 [consultado 13 Sep 2023]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2012877&info=resumen&idioma=SPA>
16. Olivares Faúndez VE, Gil Monte PR. Análisis de las principales fortalezas y debilidades del «Maslach Burnout Inventory» (MBI). *Cienc Trab*. 2009;33:160–7 [consultado 13 Sep 2023]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3054723>
17. Gilla MA, Belén Giménez S, Moran VE, Olaz FO. Adaptación y validación del Inventario de Burnout de Maslach en profesionales argentinos de la salud mental. *Liberabit*. 2019;25:179–93 [consultado 13 Sep 2023]. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272019000200004&lng=es&nrm=iso&tlng=es
18. Williamson K, Lank PM, Cheema N, Hartman N, Lovell EO. Comparing the Maslach Burnout Inventory to other well-being instruments in emergency medicine residents. *J Grad Med Educ*. 2018;10:532–6 [consultado 13 Sep 2023]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30386478/>.
19. Vargas-Benítez MÁ, Izquierdo-Espín FJ, Castro-Martínez N, Gómez-Urquiza JL, Albendín-García L, Velando-Soriano A, et al. Burnout syndrome and work engagement in nursing staff: A systematic review and meta-analysis. *Front Med (Lausanne)*. 2023;10:1125133 [consultado 13 Sep 2023]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37529242/>
20. Salamero M, Baranda Areta L. *Estudi longitudinal sobre la salut, estils de vida i condicions de treball dels MIR de Catalunya*. Barcelona: Fundació Galatea; 2018.
21. Panagioti M, Geraghty K, Johnson J, Zhou A, Panagopoulou E, Chew-Graham C, et al. Association between physician burnout and patient safety, professionalism, and patient satisfaction: A systematic review and meta-analysis. *JAMA Intern Med*. 2018;178:1317–31 [consultado 13 Sep 2023]. Disponible en: <https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2698144>
22. Ovejas López A, Izquierdo F, Rodríguez Barragan M, Rodríguez Benítez J, García Batanero M, Alonso Martínez M, et al. Burnout y malestar psicológico en los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria. *Aten Primaria*. 2020;52:608–16 [consultado 13 Sep 2023]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7637170&info=resumen&idioma=ENG>
23. Alkhamees AA, Aljohani MS, Kalani S, Ali AM, Almatham F, Alwabili A, et al. Physician's burnout during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. *Int J Environ Res Public Health*. 2023;20:4598 [consultado 13 Sep 2023]. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10001574/>
24. Olivares Faúndez VE, Mena Miranda LE, Jélvez Wilke C, Macía Sepúlveda F. Validez factorial del *Maslach Burnout Inventory Human Services* (MBI-HSS) en profesionales chilenos. *Universitas Psychologica*. 2014;13:145–60 [consultado 13 Sep 2023]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4969768&info=resumen&idioma=SPA>
25. Pradas-Hernández L, Ariza T, Gómez-Urquiza JL, Albendín-García L, de la Fuente EI, Cañadas-De la Fuente GA. Prevalence of burnout in paediatric nurses: A systematic review and meta-analysis. *PLoS One*. 2018;13:e0195039 [consultado 13 Sep 2023]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29694375/>
26. Tam CWC, Pang EPF, Lam LCW, Chiu HFK. Severe acute respiratory syndrome (SARS) in Hong Kong in 2003: Stress and psychological impact among frontline healthcare workers. *Psychol Med*. 2004;34:1197–204 [consultado 13 Sep 2023]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15697046/>
27. Hetzel-Riggin MD, Swords BA, Tuang HL, Deck JM, Spurgeon NS. Work engagement and resiliency impact the relationship between nursing stress and burnout. *Psychol Rep*. 2020;123:1835–53 [consultado 13 Sep 2023]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31510876/>.
28. Sulaiman R, Ismail S, Shraim M, el Hajj MS, Kane T, el-Awaisi A. Experiences of burnout, anxiety, and empathy among health profession students in Qatar University during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional study. *BMC Psychol*. 2023;11:111 [consultado 15 Sep 2023]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37055804/>.
29. House of Commons - Health and Social Care Committee. Workforce burnout and resilience in the NHS and social care. Second Report of Session 2021-22. Report, together with formal minutes relating to the report; 2021 [consultado 13 Sep 2023]. Disponible en: <https://committees.parliament.uk/publications/6158/documents/68766/default/>
30. Gálvez Herrer M, Gómez García JM, Martín Delgado MC, Ferrero Rodríguez M. Humanización de la Sanidad y Salud Laboral: Implicaciones, estado de la cuestión y propuesta del Proyecto HU-CI [Humanizing Healthcare and Occupational Health: Implications, State of Issue and Proposal from HU-CI Project]. *Med Segur Trab*. 2017;63:103–19.
31. Caballero Martín M, Bermejo Fernández F, Nieto Gómez R, Caballero Martínez F. Prevalencia y factores asociados al burnout en un área de salud. *Aten Primaria*. 2001;27:53–9 [consultado 18 Sep 2023]. Disponible en: <https://pmc/articles/PMC7681505/>.